

Mối liên hệ Sức khỏe răng miệng & Sức khỏe toàn thân

TS.BS Nguyễn Quốc Trưởng₁

Mục tiêu

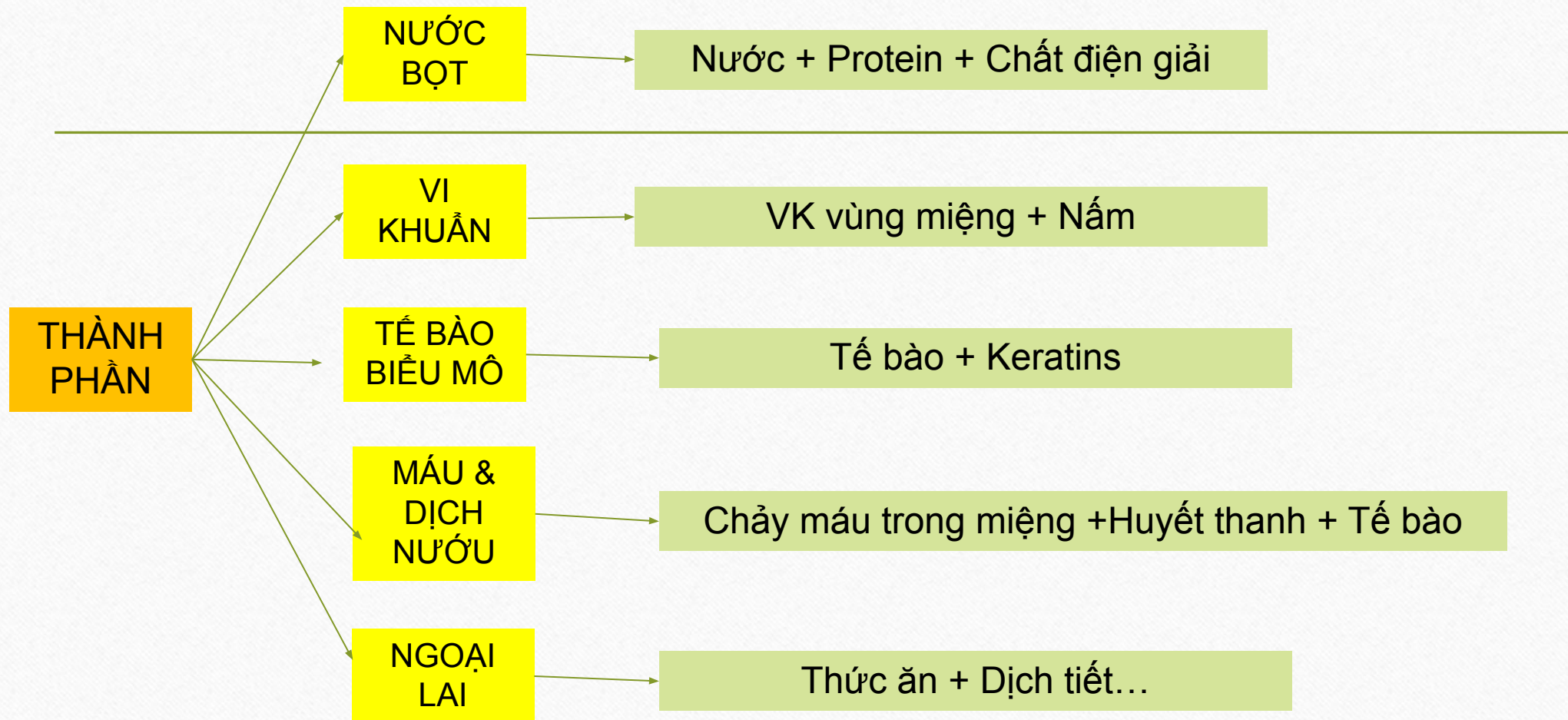
- Trình bày được vai trò của nước bọt trong sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân
- Liệt kê được những biểu hiện ở miệng đối với một số bệnh toàn thân phổ biến
- Trình bày được mối liên hệ giữa bệnh răng miệng với mắt & tai-mũi-họng
- Giải thích được mối liên quan giữa bệnh nha chu và bệnh toàn thân

Mở đầu

- Miệng $\Leftrightarrow$ Cửa ngõ của bệnh tật
- Miệng $\Leftrightarrow$ Tấm gương của sức khỏe và bệnh tật
- Miệng $\Leftrightarrow$ Hệ thống cảnh báo sớm các bệnh toàn thân

Ý nghĩa của SKRM đã vượt ra giới hạn trong miệng và tích hợp vào trong SK toàn thân

Môi trường miệng – Nước bọt



Môi trường miệng – Nước bọt

NƯỚC BỌT & SỨC KHOẺ TOÀN THÂN - CHỨC NĂNG NƯỚC BỌT

- Tiêu hoá
 - Cảm nhận vị giác
 - Bôi trơn thức ăn
 - Men tiêu hoá
- Bài tiết
 - Rượu, dược phẩm...
- Cân bằng nước
 - Khát □ khô miệng □
Uống nước
- Bôi trơn miệng: Giúp phát âm
- Dự trữ ion: Giúp tái khoáng hoá R
- Khả năng đệm: Trung hoà axit
- Vệ sinh: Làm sạch môi trường miệng
- Kháng khuẩn
- Kích thích lành thương

Bệnh toàn thân biểu hiện ở miệng

- Bệnh sởi

- Nốt Koplich xuất hiện xung quanh lỗ ống Stenon trước khi phát ban

- Bệnh thủy đậu

- Thể hiện trên môi và niêm mạc miệng (biểu hiện bệnh nặng)

- Nhiễm độc hoá chất, kim loại nặng

- Nướu – R ngả màu đen thẫm

Bệnh toàn thân biểu hiện ở miệng

- **Thiếu Vit.C**

- Nướu sưng loét dễ viêm và chảy máu
- Xương ổ R và xê măng dễ bị phá hủy
- Môi – niêm mạc miệng khô đỏ nứt nẻ

- **Thiếu Vit.A**

- Niêm mạc miệng khô dễ bị hoại tử
- Bong tróc các lớp niêm mạc

- **Thiếu Vit.D**

- Biến dạng xương hàm
- R mọc chậm, rụng chậm...

- **Thiếu Vit.B**

- Dễ tổn thương niêm mạc miệng

- **Thiếu Calci, Fluor**

- Ảnh hưởng cấu trúc men-ngà

Răng miệng & bệnh nội tiết

- Thiếu năng tuyến giáp

- Rối loạn kích thích xương hàm
- R mọc chậm và chen chúc

- Cường tuyến giáp

- Sâu răng tiến triển nhanh
- R mọc sớm và rụng sớm

- Thiếu năng tuyến cận giáp

- Xương hàm và R phát triển chậm
- R bị thiếu sản men

- Cường tuyến cận giáp

- Cấu trúc R & xương xóp , yếu
- R dễ bị sạm tủy

Răng miệng & bệnh nội tiết

- Thiếu năng tuyến yên

- XHD nhỏ □ mặt choắt
- R nhỏ và mọc chậm

- Cường tuyến yên

- XHD to quá mức
- R to và thưa
- Lưỡi to

- Thiếu năng tuyến thượng thận

- Chậm mọc R

- Cường tuyến thượng thận

- R to
- Mặt trong của má và mép môi có vết xám

Hình ảnh bất thường R

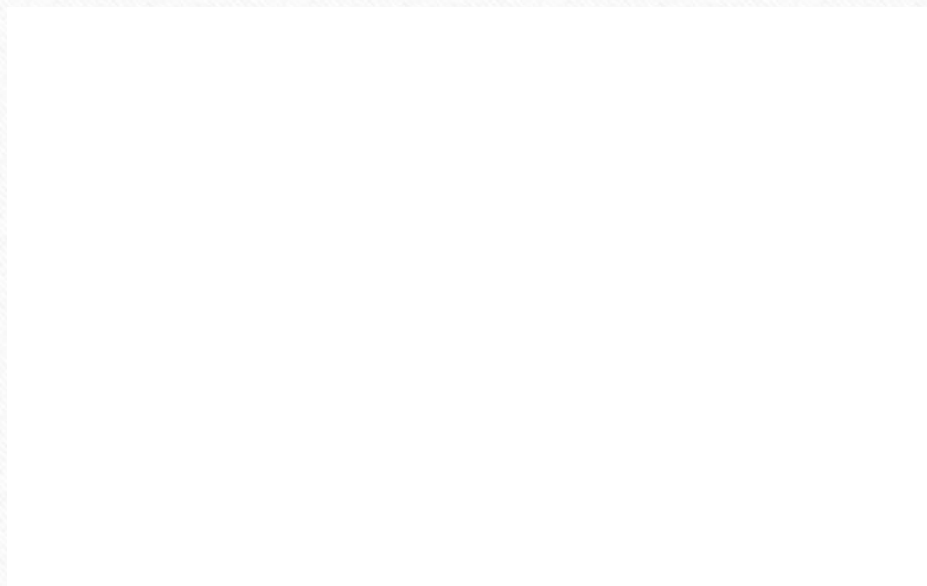


Răng to



Răng nhỏ

Hình ảnh bất thường R



R nhiễm Fluor



R nhiễm Tetra

Hình ảnh bất thường R



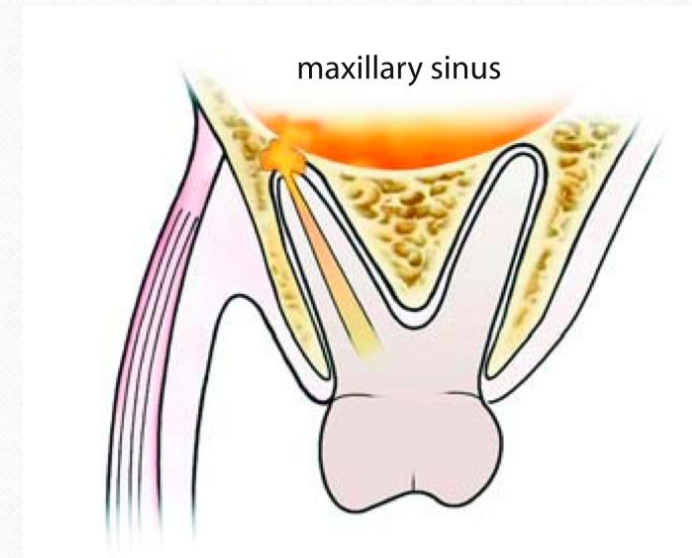
Thiếu sản men (thiếu Vit.; Ca; P...)



R cửa Hutchinson (gang mai)

Mối quan hệ với bệnh Tai-Mũi-Họng

- Viêm xoang, viêm Amidan ↔ Viêm tuỷ R, Viêm quanh chóp
- Viêm miệng ↔ Viêm họng
- Nhổ R □ đẩy chân R vào xoang hàm, thủng xoang hàm...
- Gãy XHT, xương gò má □ máu tụ trong xoang hàm
- Biến chứng mọc R khôn dưới □ Viêm thành trước họng □ Viêm amidan



Mối quan hệ với bệnh mắt

- Chấn thương XHT (Le Fort II) □ Rối loạn thị giác, loạn thị, song thị...
- Viêm chóp R (R3 trên) □ nhiễm trùng ở mắt, viêm màng bồ đào, áp xe mi mắt dưới
- Bệnh glaucoma cấp có biểu hiện đau nhức R

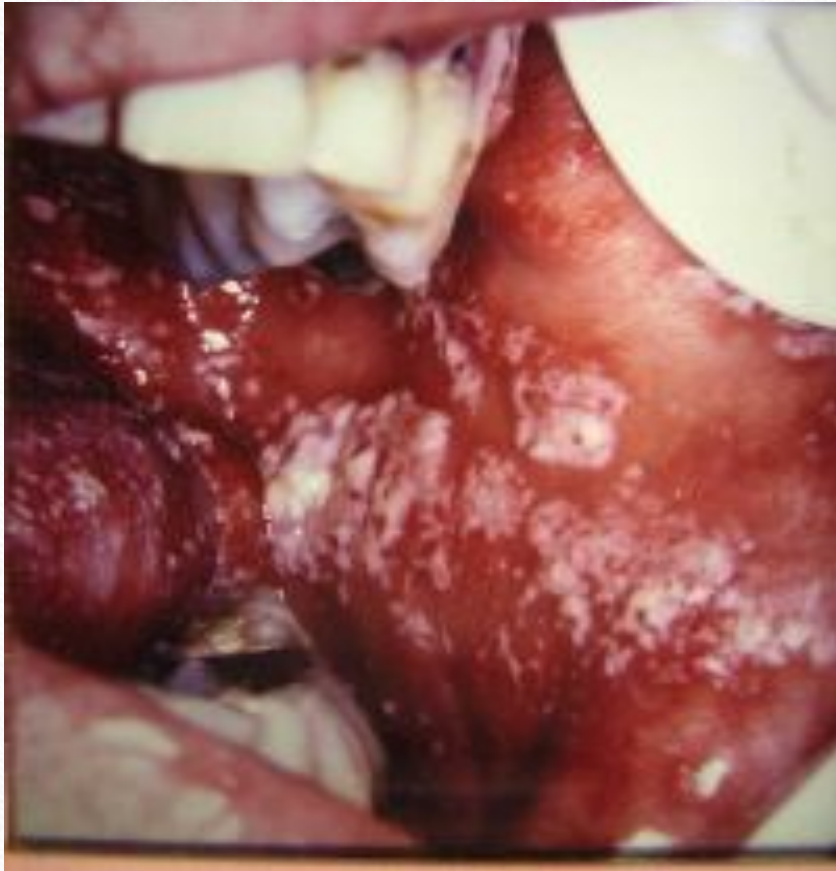


Nhiễm trùng R 13 □ áp xe hố nanh
□ nhiễm trùng mi mắt dưới

Mối quan hệ với bệnh đường tiêu hoá

- Rối loạn tiêu hoá
 - Lưỡi bẩn có màu trắng xám
- Viêm dạ dày
 - Lưỡi có màu vàng nhạt, khô
- Viêm đường ruột
 - Viêm nướu, viêm niêm mạc miệng, áp tơ...
- Nhiễm trùng răng miệng
 - Tiêu hoá kém, hấp thụ giảm, viêm đường tiêu hoá

Biểu hiện miệng ở bệnh nhân nhiễm HIV



Pseudomembranous Candidiasis

- The most frequent type in AIDS patients

Biểu hiện miệng ở bệnh nhân nhiễm HIV



Necrotizing gingivitis

- sequestrum
- necroses of papillae
- pseudo-membranes

Biểu hiện miệng ở bệnh nhân nhiễm HIV



Herpetic stomatitis

- fibrin-covered ulceration
- 10% of AIDS patients
- Treatment: Acyclovir

Biểu hiện miệng ở bệnh nhân nhiễm HIV



Hairy Leukoplakia

- always located on the margin of the tongue
- usually bilaterally
- always is white
- corrugated surfaces
- sometimes smooth

Biểu hiện miệng ở bệnh nhân nhiễm HIV



Non-Hodgkin Lymphoma

- Pyogenic ulcerated granuloma
- Related to lymphocyte B and EBV

Biểu hiện miệng ở bệnh nhân nhiễm HIV



Kaposi's Sarcoma

- Red / bluish lesion may become ulcerated
- Favorite location: laterally palate



Bệnh nha chu và bệnh toàn thân

- Viêm nha chu ảnh hưởng toàn thân

- Phát tán vi khuẩn
- Phát tán chất trung gian gây viêm và Cytokine tại chỗ □ toàn thân
- Khởi phát đáp ứng tự miễn
- Hít hoặc nuốt vào hệ hô hấp / hệ tiêu hoá

Mối liên hệ giữa Bệnh nha chu với

- BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
- BỆNH TIM MẠCH
- BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
- HÔ HẤP
- THAI PHỤ VÀ THAI NHI

Bệnh nha chu với TIỂU ĐƯỜNG

- Tác động qua lại 2 chiều
- Viêm nha chu = Biến chứng của bệnh tiểu đường
- Bệnh tiểu đường = Yếu tố nguy cơ của NCV
- Nguy cơ tiêu xương ổ ở bệnh nhân tiểu đường
 - TĐ có kiểm soát = gấp 3 lần NCV không tiểu đường
 - TĐ không kiểm soát = gấp 11 lần NCV không tiểu đường

Bệnh nha chu với TIỂU ĐƯỜNG

- Ảnh hưởng TĐ □ NCV

↑ cytokines và hóa chất trung gian viêm

PGE2, IL-1, IL-6, TNF- α

↑ AGEs trong mô NC ảnh hưởng vi tuần hoàn

↑ nguyên bào xương chết nhiều và sớm hơn

↑ **hủy hoại mô liên kết**

↓ chức năng BC đa nhân trung tính

↓ tạo collagen,



- **Mô nha chu**

- Dễ nhiễm khuẩn hơn
- Bị phá huỷ nhanh hơn
- Khó lành thương hơn

Bệnh nha chu với TIỂU ĐƯỜNG

- **Ảnh hưởng NCV □ Bệnh TĐ**

- **Nhiễm khuẩn mô NC**

- □ IL-6, TNF-alpha, CRP, Fibrinogen
- □ Tăng đề kháng Insulin
- □ Giảm kiểm soát đường huyết



- **Bệnh TĐ**

- Tăng biến chứng tim mạch và thận
- Điều trị NCV □ Cải thiện kiểm soát đường huyết
 - □ Giảm AGEs, HbA1c, TNF-alpha

Bệnh nha chu với VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

- Có liên quan mật thiết giữa VKDT và NCV
 - Tỷ lệ NCV tăng gấp 2 ở BN VKDT
 - Tỷ lệ VKDT tăng gấp 4 ở BN NCV
- Sự tương đồng giữa NCV & VKDT
 - Viêm mãn tính
 - Phá huỷ cấu trúc xương & mô mềm nâng đỡ
 - Cùng có đáp ứng miễn dịch tế bào

Bệnh răng miệng/nha chu & tim mạch

- Có mối liên hệ giữa viêm nha chu với bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não” (Mattila-1989; De Stefano- 1993)
- Tương quan giữa tình trạng răng miệng thậm chí mạnh hơn các yếu tố cholesterol, BMI, tiểu đường, hút thuốc. (W.J.Loesche & A. Schork)
- Tuy vậy “Khuyến điều trị nha chu để phòng ngừa tim mạch chưa được đảm bảo về bằng chứng khoa học” (Demmer R.T. 2006)

Bệnh R miệng/nha chu & bệnh đường hô hấp

- Vi khuẩn được hít vào trực tiếp
- Enzyme từ vi khuẩn phá huỷ protein bảo vệ trong nước bọt chất nhầy → tổn thương biểu mô đường hô hấp
- Cytokine viêm → tổn thương biểu mô đường hô hấp

Bệnh nha chu với thai phụ và thai nhi

- Có tình trạng sinh non: sinh trước tuần 37
- Có tình trạng sinh nhẹ cân.
- Nhưng chưa đủ bằng chứng xác định viêm nha chu gây ra các tình trạng trên, nhưng mọi nhiễm trùng hệ thống kích thích phản ứng viêm và đường lan truyền phản ứng viêm chịu trách nhiệm đầu tiên

(Danolu 2010)

TÀI LIỆU THAM KHẢO bài 5

1. Hoàng Tử Hùng- *Mối liên hệ sức khoẻ răng miệng và toàn thân*.
www.hoangtuhung.com
2. Cao Hữu Tiến. *Môi trường miệng và mối liên hệ với sức khoẻ toàn thân*. Giáo trình RHM- TĐHYK Phạm Ngọc Thạch. Lưu hành nội bộ (2017)
3. Giáo trình RHM / Khoa RHM ĐHYD Huế (2007)
4. Mattila KJ, Nieminen MS, Valtonen VV, et al. Association between dental health and acute myocardial infarction. Br Med J 1989; 298:779-81
5. DeStefano F, Anda RF, Kahn HS, Williamson DF, Russell CM. Dental disease and risk of coronary heart disease and mortality. Br Med J 1993;306:688-91.
6. Demmer, R.T., Desvarieux, M.: Periodontal infections and cardiovascular Disease: The heart of the matter, JADA, Vol. 137 (supl.) October 2006, 14-20